

Desesperanza creativa

Protocolo clínico - Para el terapeuta ACT

FUNDAMENTO Y OBJETIVO

La desesperanza creativa es una intervención ACT de las primeras sesiones. Busca que el paciente contacte con la ineffectividad de sus estrategias de control del malestar a largo plazo - no para desesperanzarse, sino para abrir espacio a una nueva dirección: la flexibilidad psicológica y los valores.

CUANDO USARLA

- Pacientes con alta evitación experiencial y repertorio de control rígido.
- Cuando el paciente llega a terapia esperando 'eliminar' el malestar.
- Antes de introducir aceptación.
- Con cuidado en pacientes con alta desesperanza clínica (evaluar riesgo primero).

ESTRUCTURA DE LA INTERVENCIÓN

Paso 1: Identificar el problema central

Preguntar al paciente que lo trae a terapia. Que quiere cambiar, reducir, eliminar.

- Sin juzgar las estrategias
- Tono curioso, no confrontativo

Paso 2: Mapear las estrategias usadas

Listar todo lo que el paciente hizo para manejar el problema. Sin evaluación.

- Incluir: evitación, supresión, distracción, búsqueda de seguridad, etc.

Paso 3: Evaluar el resultado a largo plazo

Para cada estrategia: funcionó? El problema disminuyó? La vida mejoró?

- Distinguir alivio a corto plazo (frecuente) de mejoría sostenida (rara)

Paso 4: Contactar con el costo

Cuanto esfuerzo, tiempo y vida costó ese control? Que se perdió en el camino?

- Aquí emerge la DC: el control tiene costo y no resuelve

Paso 5: Abrir la pregunta

Y si el problema no fuera el malestar sino la lucha con el malestar?

- No dar la respuesta: dejar la pregunta
- Conectar con valores a continuacion

FRASES CLINICAS UTILES

- 'Que hiciste para que esto mejorara? Y cuanto mejoro?'
- 'Si esa estrategia hubiera funcionado, estarias aqui hoy?'
- 'No digo que lo que hiciste estuviera mal. Digo que quiza el problema no era el malestar.'

- Clave clinica: la DC no es confrontacion ni pesimismo. Es compasion radical: acompañar al paciente a ver lo que ya sabe pero evita mirar.